



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 20-12-2024 10:56:05

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Victor Fernando Pizarro Maureira	Rut : 7.807.733-6	N° Archivo : 0902744	N° Epicrisis
Edad : 70a 2m 18d	Fecha Nacto : 02/10/1954	Sexo : Masculino	424681
Dirección : Av Ramon Subercaseux S/N La Puntill	Comuna : Pirque	Teléfono : 9 3561 7920	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim	Fecha Ingreso : 17/12/2024	22:06	Días Estadía : 3
Unidad de Egreso : Utim	Fecha Egreso : 20/12/2024	10:12	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Ingreso UTIM 2024

Datos del Paciente
Nombre : Victor Pizarro Maureira
RUT : 7807733-6
Edad : 70
FI hospital: 17/12/24
FI PAM/UTIM: 18/12/24

Antecedentes:
Médicos: HTA, Asma, Artritis reumatoide, TEP agosto 2021 y 2022, enfermedad inflamatoria intestinal Infección por H. pylori erradicada

Quirúrgicos: Colectectomía, Hernioplastía inguinal derecha, artroplastia de cadera

Fármacos: Leflunomida 20 mg c/24hrs vo, Metotrexato 2,5 mg 5 comp c/24 hrs vo solo los jueves, Ácido fólico 1 mg c/24hrs vo, Budesonida 9 mg 1 comp c/24 hrs vo, Bisoprolol 5 mg, 1/4 comp c/24hrs vo, Salbutamol 2 puff SOS por AEC, Cotrimoxazol forte 1 comp L-M-V, Omeprazol 20 mg c/24hrs vo, Carbonato de calcio 500mg, TACO , hidroclorotiazida 1 comp c/24hrs.

Hospitalizaciones:
-Dic/21 TEP + síndrome diarreico agudo con shock hipovolémico, hematoquezia y síndrome consuntivo.
-20/02-07/06/2022 Neumonía grave por COVID 19 requerimientos de VMI + TQT

Alergias: -
Hábitos: OH (-), TBQ suspendido IPA 14, drogas (-)
Social/Basal: 935617918 (Alicia, comadre) otros números 935617920/988843117 / 228546561. Dependiente severo. Postrado desde la hospitalización de COVID-19.

Motivo de consulta en SU: I.

*Pcte. Si bien orientado no entrega buena historia y sin conocimiento adecuado de sus patologías, me comunico con convivientes quien complementan la historia.

Hombre de 70 años con antecedentes descritos, desde hace 4 meses con deposiciones sanguinolentas y dolor abdominal

Fecha Epicrisis : 20/12/2024 10:56

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 20-12-2024 10:56:05

Página 2 de 3

intermitente, últimas 2 semanas con tos con expectoración mucopurulenta, asociado a compromiso del estado general, disnea des esfuerzo, fiebre cuantificada en 38,5 últimos días, evoluciona con episodios de lipotimia.

Al interrogatorio dirigido refiere epistaxis, sudoración nocturna, polaquiuria y retención urinaria. Convivientes refieren además adherencia irregular de farmacos. Niega hematemesis, disfagia. Dado persistencia de síntomas es traído a SU donde ingresa en malas condiciones generales, FC 131 PA 85/68 PAM 36.5 Sat 93% 2 lts por naricera. Al examen físico se describe Conciente, Tibio a distal, MP disminuido, Crepitos difusos, Buena mecánica ventilatoria, Abdomen BDI, Ple izquierdo con lesión en planta, impresiona úlcera pequeña EEL Edema ++, fovea +

Laboratorio de ingreso 17/12 glicemia 229 Na 133 K 4.55 Cl 102 BUN 47 Crea 1.94 Hb 6, Leucocitos 400 Plaquetas 4000 PCR 95 INR 1.26 TTPK 28 BT 2.67/1,76 FA 227 GGT 329 GOT 68 GPT 42 LDH 268 Albúmina 1.9 Ph 7.49 HCO3 25

Angio TC + TC AP: sin TEP Opacidad parenquimatosas pulmonares y nódulos centrolobulillares bilaterales de etiología inflamatoria infecciosa. Ateromatosis cálcica aórtica y coronaria.

Estigmas de daño hepático crónico. Leve ascitis.

Se complementa estudio con hemograma 18/12 Hto 15.5, Hb 5.2, leuco 0.18 (RAN 0.03, RAL 0.11), plaq 3000 Frotis: eritrocitos anisocitosis +++, macrocitosis +, poiquilocitosis ++, target cells ++, dacriocitos +, esferocitos +, policromatofilia +, anisocromía ++, cuerpos de Howell ¿ Jolly +

Fibrinógeno 421 Reticulocitos 0.2% VHS 58

Se realiza manejo transfusional y se traslada a UTIM para continuar manejo.

Examen físico ingreso: (Realizado en SU 17:30)

Consciente lúcido orientado en espacio, parcialmente en tiempo. Sin focalidad neurológica evidente.

Mucosa oral seca, impresiona sin lesiones agudas. paladar sano. Llene capilar 3 seg.

Card/Resp: No realizo por falta de fonendo en unidad.

Abd: Distendido, blando depresible indoloro. s/s irritación peritoneal. No logra palpar vísceras.

Ext: Inferiores edema en bota, sin signos de TVP.

Diagnósticos Ingreso:

1.-Pancitopenia severa

a.-Anemia macrocítica normocromica hipórregenerativa

b.- Trombocitopenia severa

c.- Leucopenia/neutropenia profunda

d.- Obs intoxicación por metotrexato + pérdidas digestivas

2.- Neutropenia febril alto riesgo

a.- Foco respiratorio-NAC

3.- Insuficiencia respiratoria aguda parcial

a.- Crisis de asma mal control

4.- AKI sobre ERC

a.- obs prerenal

5.- Síndrome diarreico crónico obs EIL descompensada

Antecedentes: HTA, Asma, Artritis reumatoide, TEP agosto 2021 y 2022, enfermedad inflamatoria intestinal Infección por H. pylori erradicada

Hemodinamia: paciente con sepsis de foco respiratorio, con buena respuesta inicial a volumen, persiste taquicardia sinusal.

Ventilatorio: IRA parcial secundario a NAC multilobar y crisis de asma leve, manejo con antibióticos, corticoides inhalados y sistémicos y SABA.

Infeccioso: NAC multilobar con nódulos centrolobulillares bilaterales asociado a NFAR, manejo inicial con Tazonam.

Del estudio microbiológico destaca: HMC 1 y 2 (+) para bacilos gram negativos, COVID (-), PVR (-), CET (P), PCR TBC (P), BK 1 y 2 (P).

Dado bacteriemia por BGN se cambia Tazonam por Imipenem.

Hematológico: paciente con pancitopenia severa con anemia no regenerativa macrocítica, RAN 0 y plaquetas 4.000 al ingreso. Hemograma sin blastos ni esquistocitos. Dado antecedente de uso diario de metotrexato se inicia leucovorina y se transfunden GR y plaquetas.

Estudio:

- TAC TAP sin poliadenopatías, hepato ni esplenomegalia.

- Niveles de metotrexato: <0.04 (puede estar bajo en intoxicaciones crónicas), VHB (-) VHC (-) EFP en sangre sin peak

Fecha Epicrisis : 20/12/2024 10:56

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:32

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 20-12-2024 10:56:05

Página 3 de 3

monoclonal, hipogamaglobulinemia.

- Pendientes en sistema: IgM CMV e IgM VEB, VDRL, folato sérico.

- Solicito: VIH, B12.

En síntesis, la principal sospecha es intoxicación crónica por metotrexato pero no es descartable compromiso medular primario (mielodisplasia vs mielofibrosis). Evaluado por hematología, estaba en plan de estudio medular.

Gastro: Paciente con antecedente de E.Chron con compromiso ileocolónico sin complicaciones, último control en junio 2023, sin adherencia a budesonida oral. Ingresa con diarrea sanguinolenta de 4 meses de evolución, se inicia hidrocortisona EV en altas dosis.

Pendiente coprocultivo y toxinas de CD.

Nefrológico: crea 2022 1.3, ingresa con AKI KDIGO 1 con crea de 2.

Paciente con mala evolucion clínica durante la madrugada del 20/12. Con aumento de requerimientos de oxígeno hasta 4 litros por naricera, sin respuesta a terapia broncodilatadora ni aspiracion.

Evoluciona con aumento de requerimientos de oxígeno, mala mecánica respiratoria, uso de musculatura accesoria, taquicardia 140 y mala perfusión distal, conecto a CNAF flujo 60/FIO2 80% sin respuesta. Paciente no candidato a VMI dado dependencia para actividades básicas de la vida diaria. Indico morfina EV para alivio de disnea.

Aviso a tutor sobre la gravedad del paciente, asisten a verlo.

Paciente fallece el 20/12/2024 a las 4:15 am. Constató ausencia de pulso carotídeo y ausencia de actividad eléctrica en el monitor.

Asisten familiares a retirar certificado de defunción. Entrego a Julio, tutor.

Diagnóstico de Egreso

NEUMONIA BACTERIANA NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE -

SEPSIS DEBIDA A OTROS ORGANISMOS GRAMNEGATIVOS - Shock septico de foco pulmonar

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecido

Plan Post Alta

No aplica

Indicaciones

Tipo de Reposo :

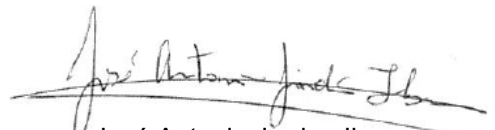
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



José Antonio Jordan Ibarra
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 20/12/2024 10:56

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:32

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar